

Physioguide — Evidencia — Clusters Tier A/B/C codo, muñeca y mano

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Capa: Fase 3 evidence DB

Regla: un cluster es un patrón. Tests aislados no diagnostican. NUNCA inventar Sn/Sp. NUNCA “STC / De Quervain / TFCC / UCL / LET confirmado”. Cribado cervical si hormigueo atípico.

Etiquetas de confianza — nunca convertir positivo en diagnóstico definitivo:

- Tier — Significado — Uso en app
- A — Validado / mejor respaldo relativo — Combinación estudiada o CPG (historia + provocación) — Aumenta/disminuye sospecha con lenguaje probabilístico
- B — Evidencia moderada — Batería clínica con respaldo en revisiones/series — Aumenta sospecha; sin LR combinado sólido
- C — Batería clínica — Útil en consulta; combinación no validada como cluster formal — Orienta exploración; no probabilidad post-test formal

CLUSTER A: TÚNEL CARPIANO (STC)

Componentes: parestesias nocturnas en territorio mediano ($1.^{\circ}$ – $3.^{\circ}$ ± mitad radial anular) ± sacudir la mano + Durkan (compresión carpiana) ± Phalen ± Tinel ± diagrama de Katz. Déficit de abducción del pulgar (APB) = más grave.

Cita: D'Arcy & McGee *JAMA* 2000; MacDermid & Wessel; JOSPT CTS CPG (Erickson 2019); Durkan 1991 (serie; precisión posterior mixta). Historia pesa tanto o más que un test.

AI: Compatible con túnel carpiano. Durkan/Phalen/Tinel apoyan; no confirman. Negativos no descartan. Meñique solo !' cubital. Cuello + brazo !' Wainner.

CLUSTER A: DE QUERVAIN (1.er compartimento)

Componentes: dolor en estiloides radial + palpación del 1.er compartimento + uso del pulgar + WHAT ± Finkelstein verdadero (no Eichhoff como único criterio).

Cita: Goubau WHAT 2014; Finkelstein vs Eichhoff (Dawson/Mudgal). Cluster clínico, no oro.

AI: Compatible con De Quervain. Eichhoff (pulgar en el puño) da falsos positivos. FOOSH + tabaquera !' escafoides primero. Base del pulgar + pinza en mayores !' CMC.

CLUSTER A: RADICULOPATÍA CERVICAL (Wainner — siempre cribar en codo/mano)

Componentes: cuello + irradiación + Spurling + ULTT + distracción + rotación cervical limitada.

Cita: Wainner *Spine* 2003; JOSPT Neck CPG.

AI: Sube cervical. No fuerces LET ni STC si el patrón es de raíz.

CLUSTER B: EPICONDILALGIA LATERAL (LET)

Componentes: dolor epicóndilo lateral + palpación familiar + Cozen + Mill ± Maudsley + agarre/ratón. Sin déficit neurológico dominante.

Cita: Coombes/Vicenzino BJSM; Zwerus (tests aislados limitados).

AI: Compatible con tendinopatía extensora. Maudsley no = nervio radial. Dolor en antebrazo proximal o debilidad de extensión !' túnel radial / PIN / C7.

CLUSTER B: EPICONDILALGIA MEDIAL

Componentes: dolor epicóndilo medial + palpación + flexión de muñeca y/o pronación resistida. Cribado cubital $4.^{\circ}$ – $5.^{\circ}$ obligatorio.

AI: Compatible con flexor-pronador. Lanzador + valgo dinámico !' no olvidar UCL.

CLUSTER B: TÚNEL CUBITAL

Componentes: parestesias 4.º–5.º + empeora al flexionar/apoyar el codo + Tinel cubital / elbow flexion ± Froment ± Wartenberg.

Cita: Buehler elbow flexion; Novak/Mackinnon.

AI: No lo llames STC. Déficit motor (Froment) sube gravedad. Diferenciar Guyon (muñeca, a menudo motor o dorso respetado según zona).

CLUSTER B: ROTURA DE BÍCEPS DISTAL

Componentes: pop antecubital al cargar + pérdida de contorno + debilidad de supinación + hook test ausente ± squeeze sin supinación.

Cita: O'Driscoll hook 2005 (completo); Ruland squeeze 2005.

AI: Sospecha alta de rotura completa !' derivación médica. Hook enganchable no descarta parcial. No LET.

CLUSTER B: TFCC / DOLOR CUBITAL DE MUÑECA

Componentes: dolor lado meñique + fovea ± press test ± carga cubital ± dolor a la pronosupinación. Añadir piano-key si inestabilidad DRUJ.

Cita: Tay fovea 2007 (serie); Lester press; exploración ulnocarpiana.

AI: Compatible con TFCC en cluster. Nunca "TFCC confirmado". Diferenciar ECU, LT, fractura estiloides cubital, DRUJ.

CLUSTER C: UCL DE CODO (lanzadores)

Componentes: historia de overhead/lanzamiento + dolor medial en aceleración + moving valgus ± milking ± valgo a 30°.

Cita: O'Driscoll moving valgus 2005. Evidencia posterior mixta.

AI: Compatible con insuficiencia UCL clínica. No rotura confirmada. Cribado cubital.

CLUSTER C: INESTABILIDAD ESCAFOLUNAR

Componentes: FOOSH o carga + dolor dorsal SL + Watson ± ballottement SL. Imagen de escafoides primero si tabaquera.

Cita: Watson 1988. Precisión variable.

AI: Compatible con inestabilidad SL. Watson no confirma. RX/RMN si persiste.

CLUSTER C: INESTABILIDAD DRUJ

Componentes: trauma rotacional + dolor al girar + piano-key asimétrico doloroso ± press test.

AI: Compatible con DRUJ. Laxitud bilateral indolora "" patología. Solapa con TFCC.

CLUSTER C: INESTABILIDAD LT

Componentes: dolor cubital dorsal + ballottement/Reagan/Kleinman + menos fovea que TFCC típico.

AI: Diferencial de TFCC. No confirmes con un shear.

CLUSTER C: PLRI / LCL

Componentes: luxación o caída + aprensión al empujarse con palma supinada + chair/tabletop ± pivot-shift (clínico experto).

Cita: O'Driscoll PLRI.

AI: Compatible con inestabilidad posterolateral. No LET. No pedir pivot-shift domiciliario.

CLUSTER C: RIZARTROSIS CMC

Componentes: dolor base pulgar + pinza + grind ± lever + palpación CMC. Edad típica.

AI: No De Quervain si el 1.er compartimento no duele.

CLUSTER C: TRÍCEPS DISTAL

Componentes: pop posterior + debilidad de extensión de codo + defecto palpable ± imposibilidad de extensión contra gravedad.

AI: Sospecha de rotura !' imagen/derivación. No olecranon bursitis sola si hay déficit de extensión.

CLUSTER C: TÚNEL RADIAL vs LET

Componentes: dolor antebrazo proximal dorsal > epicóndilo ± Maudsley/Cozen con dolor no en hueso ± dolor a la supinación resistida ± palpación sobre arcade of Frohse. PIN = más motor (extensión dedos).

AI: No etiquetas LET si el epicóndilo está silente y duele el músculo. Cuello siempre en el diferencial.

CLUSTER (dedos — ya activos)

Trigger A1, jersey (FDP), mallet (extensor IFD), UCL pulgar: ver clusters-finger-hand.md. Añadir ilustración/ vídeo de catálogo; el razonamiento clínico ya existe.

COEXISTENCIAS FRECUENTES (no mutuamente excluyentes)

- LET + C6–C7
- LET + túnel radial
- Medial epicondylalgia + cubital + UCL (lanzador)
- STC + De Quervain + CMC (uso de pulgar/muñeca)
- TFCC + DRUJ
- Escafoides óseo + “esguince” de muñeca

AI: Permite dos hipótesis. No fuerces una etiqueta.

